

Svrbenie (pruritus) na dialýze: prečo sa udávaná prevalencia líši dvojnásobne a čo pacient sám nepovie

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 10.09.2026

Pruritus spojený s chronickou chorobou obličiek patrí k symptómom, ktoré dialyzovaného pacienta obťažujú najviac a v ambulancii sa spomenú najmenej. Nová turecká štúdia s kombinovaným kvantitatívno-kvalitatívnym dizajnom priniesla údaj, ktorý sa rýchlo rozšíril: stredne ťažké až ťažké svrbenie malo **16,3 %** hemodialyzovaných.

To číslo je vecne správne – a zároveň sa nedá použiť ako odpoveď na otázku „koľko našich pacientov svrbí“. Dôvod je poučný a týka sa každého symptómového ukazovateľa, ktorý meriame dotazníkom.

Čo štúdia urobila

Autorky použili sekvenčný vysvetľujúci zmiešaný dizajn: prierezovú kvantitatívnu fázu a na ňu nadväzujúcu kvalitatívnu fázu s reflexívnou tematickou analýzou. Prebehla v troch dialyzačných strediskách pridružených k univerzitnej nemocnici v Ankare od októbra 2025 do januára 2026. Z približne 520 dialyzovaných dospelých sa zúčastnilo **294, teda približne 57 %** (vlastný orientačný prepočet z približného menovateľa); dôvody neúčasti zvyšných pacientov práca neuvádza.

Závažnosť sa merala tureckou verziou päťdimenzionálnej škály svrbenia (5-D), ktorá hodnotí trvanie, intenzitu, vývoj, obmedzenie činností a rozsah postihnutia. Priemerné skóre bolo $8,00 \pm 3,21$ pri nameranom rozsahu 5,00 až 19,75 a vnútornej konzistencii 0,77.

Kategória podľa 5-D	Skóre	Počet	Podiel
„Bez pruritu“	5–8	193	65,6 %
Mierne	9–11	53	18,0 %
Stredne ťažký	12–17	37	12,6 %
Ťažký	18–21	11	3,7 %
Veľmi ťažký	≥ 22	0	0 %

Aspoň mierne svrbenie (5-D ≥ 9) teda malo 101 pacientov (34,4 %) a stredne ťažké až ťažké 48 pacientov (16,3 %). Údaj 34,4 % pritom v abstrakte nie je – kto cituje len abstrakt, nájde tam iba 16,3 %.

Prečo 16,3 % nie je „prevalencia svrbenia pri dialýze“

- Kategória „bez pruritu“ neznamená, že pacienta nesvrbí.** Znamená skóre 5 až 8 na škále, ktorej minimum je 5. Pacient, ktorého občas a mierne svrbí, sa do tejto kategórie dostane bez ťažkostí.
- Hranica pre „stredne ťažký až ťažký“ nepochádza z pôvodnej publikácie škály.** Práca, ktorá 5-D zaviedla, uvádza len teoretický rozsah 5 až 25 a žiadne kategórie závažnosti nedefinuje. Použitý prah pochádza z neskoršej taiwanskej práce, ktorá kategórie odvodila lineárnou regresiou na číselnej škále u 409 dialyzovaných v jedinom centre – bez analýzy ROC a bez uvedenia senzitivity či špecificity. V tejto štúdii sa navyše skóre 11,5 zaokrúhľovalo nahor na 12, takže skutočný prah bol 11,5.
- Škála 5-D bola vyvinutá na meranie zmeny, nie na skrining.** Jej pôvodným určením bolo sledovať vývoj svrbenia v čase v klinických skúšaniach u pacientov, ktorí pruritus majú – prítomnosť svrbenia bola vstupným kritériom. Použitie ako prevalenčného skriningu v neselektovanej dialyzačnej populácii je mimo overeného účelu nástroja.

4. **Vylučovacie kritériá súbor systematicky očistili.** Vyradení boli pacienti s psychiatrickou diagnózou alebo klinicky zjavným psychiatrickým stavom, s aktívnym dermatologickým ochorením, s cholestázou, s malignitou, s akútnou infekciou a tí, ktorí v poslednom mesiaci začali novú systémovú antipruritickú liečbu. Vzniká tak „čistý“ obraz, ktorý sa vzdáva bežnej ambulancii – a vylúčenie psychiatrickej komorbidity pravdepodobne záťaž symptómom podhodnocuje, keďže depresia a úzkosť vnímanie aj hlásenie svrbenia priamo ovplyvňujú.
5. **Iné kohorty udávajú výrazne viac.** Francúzska prospektívna multicentrická štúdia so systematickým skríningom udáva stredne ťažký až ťažký pruritus u 23,5 %, novšie európske prehľady 31 až 40 %. Rozdiel autorky samy pripisujú odlišným nástrojom a prahom.

Praktický dôsledok: **prevalencia symptómu je funkciou toho, čím a s akou hranicou ho meriame.** Číslo 16,3 % platí pre túto škálu, tento prah a tento súbor. Prenášať ho na slovenskú dialyzačnú populáciu ako „každý šiesty“ by bolo nepresné v oboch smeroch.

Čo je na práci naozaj cenné

Ťažisko hodnoty nie je v prevalencii, ale v dvoch ďalších zisteniach.

Prvé: liečba, ktorú pacienti dostávajú, im väčšinou nepomáha. Nejaký liek na svrbenie pravidelne užívalo 212 z 294 pacientov (72,1 %), z toho perorálne antihistaminiká 143 (48,6 %) a krémy alebo emoliená 96 (32,7 %). Účinok hodnotili takto:

Vnímaný účinok	Počet	Podiel z 212 užívateľov
Žiadny	100	47,2 %
Krátkodobý (≤ 24 h)	78	36,8 %
Dlhodobejší (> 24 h)	34	16,0 %

Takmer polovica liečených teda nemá zo svojej liečby žiaden úžitok. Údaj sa vzťahuje na akúkoľvek antipruritickú liečbu, nie osobitne na antihistaminiká — tie sú len najčastejšie predpisovanou skupinou – lieky, ktorých neúčinnosť pri uremickom prurite je patofyziologicky očakávaná, pretože svrbenie tu nie je histamínovo sprostredkované.

Poznámka k údajom: pôvodná tabuľka uvádza tieto podiely vzťahované na celý súbor 294 pacientov (34,0 %, 26,5 % a 11,6 %). Vyššie uvedené podiely sú prepočítané na 212 skutočných užívateľov liekov, čo je klinicky zmysluplnejší menovateľ.

Druhé: pacienti symptóm nehlásia. Kvalitatívna fáza zahrnula všetkých 48 osôb so stredne ťažkým až ťažkým svrbením, každú aspoň v dvoch pološtruktúrovaných rozhovoroch. Vynorili sa štyri témy: bremeno pruritu (narušený spánok, emočná záťaž, stigma, kolísanie intenzity a jeho prijímanie ako nevyhnutnej súčasti liečby), zvládacie stratégie (chlad, emoliená, lieky s útlmom), **bariéry v komunikácii** (váhanie ozvať sa, keď je personál zaneprázdnený, alebo keď má pacient pocit, že sa symptóm zľahčuje) a očakávania od starostlivosti (rozpor medzi očakávaným riešením a vnímaným dočasným efektom).

Práve táto časť vysvetľuje, prečo je pruritus v dokumentácii podhodnotený: nejde o to, že pacienti nesvrbia, ale že sa nepýtame a oni sami tému neotvoria.

Asociácie, ktoré sa nesmú prečítať naopak

Vo viacrozmernom modeli boli s vyšším rizikom stredne ťažkého až ťažkého svrbenia spojené komorbidné chronické ochorenie (pomer šancí 2,399; 95 % IS 1,126–5,112) a *predchádzajúca edukácia o prurite* (3,145; 1,258–7,859), s nižším rizikom manželský stav (0,418; 0,202–0,867). Pohlavie ani vek významné neboli.

- **Edukácia svrbenie nezhoršuje.** Ide o učebnicovú protopatickú zaujatosť: edukáciu dostali práve tí, ktorí mali ťažšie príznaky. Autorky to samé pripúšťajú a označujú to za reaktívne poskytovanie starostlivosti. Číslo nemožno interpretovať prognosticky ani kauzálne.
- **Manželstvo je zástupná premenná** pre psychosociálnu podporu, možno aj pre ochotu nahlásiť symptómy – nie je to ochranný faktor.

- **„Komorbidita“ je binárny súhrn** spájajúci diabetes, hypertenziu a srdcové ochorenie; nehovorí, ktorá z nich je relevantná.
- **Model je poddimenzovaný.** Na 48 udalostí pripadá šesť prediktorových stupňov voľnosti a odhad pre edukáciu stojí na deviatich udalostiach v 27-člennej exponovanej skupine, čomu zodpovedajú aj široké intervaly.
- **Chýba adjustácia na klinické determinanty.** V práci sa nevyskytuje Kt/V, fosfát, vápnik, parathormón, albumín, β 2-mikroglobulín, hemoglobín ani xeróza – teda presne tie premenné, ktoré pri uremickom prurite zvažujeme ako prvé.

Vecná kontrola tvrdení

Tvrdenie	Verdikt	Presná interpretácia
Stredne ťažký až ťažký pruritus malo 16,3 % pacientov	Potvrdené	48 zo 294 pri prahu 5-D $\geq 11,5$. Platí pre tento nástroj a prah, nie ako všeobecná prevalencia.
Svrbenie akéhokoľvek stupňa malo 34,4 %	Číslo potvrdené, formulácia nepresná	101 z 294 zodpovedá 5-D ≥ 9 , teda aspoň miernemu svrbeniu podľa Laiových kategórií (9 – 11 mierne, 12 – 17 stredne ťažké). Nejde o „akýkoľvek stupeň“: škála má minimum 5 a pásmo 5 – 8 zodpovedá NRS = 0. Údaj je len v plnom texte, nie v abstrakte.
Zvyšných 65,6 % pacientov nesvrbí	Nesprávne	Kategória zodpovedá skóre 5–8 na škále s minimom 5; mierne alebo občasné svrbenie do nej spadá.
Prah ≥ 12 pochádza z pôvodnej publikácie škály 5-D	Nesprávne	Pôvodná práca kategórie závažnosti nedefinuje. Prah pochádza z neskoršej jednocentrickej taiwanskej práce (409 pacientov). Tá ROC analýzu urobila — plocha pod krivkou bola 0,915 (95 % IS 0,889 – 0,941) pre stredne ťažký pruritus podľa NRS ≥ 4 —, samotné deliace body však odvodila z rovnice lineárnej regresie, nie z ROC. Pri prahu 12 mala senzitivitu 75 % a špecifickosť 89,3 %; autori sami žiadajú externú validáciu.
Predchádzajúca edukácia je spojená s ťažším svrbením	Potvrdené, ale zavádzajúco	Ide o obrátenú príčinnosť: edukáciu dostali pacienti s horšími príznakmi. Autorky to samé uvádzajú.
Takmer polovica liečených nemá zo svojej liečby účinok	Potvrdené	100 z 212 užívateľov akejkohoľvek antipruritickej liečby — údaj sa nevzťahuje osobitne na antihistaminiká. Tie sú len najčastejšie predpisovanou skupinou (143 z 294) a pri uremickom prurite nemajú patofyziologické opodstatnenie; štúdiá však ich samostatnú účinnosť nehodnotila.
Štúdiá hodnotí modernú liečbu (difelikefalín, gabapentinoidy, fototerapiu)	Nesprávne	Tieto možnosti sa v práci vôbec nevyskytujú. Nemožno ju citovať v terapeutickom kontexte.

Čo z toho vyplýva pre dialyzačnú ambulanciu

1. **Pýtať sa aktívne a pravidelne.** Bez cielenej otázky sa o symptóme nedozvieme - to je najlepšie doložené zistenie celej práce. Stačí jedna otázka pri mesačnej kontrole.
2. **Použiť jeden nástroj a držať sa ho.** Číselná škála 0 až 10 alebo 5-D sú obe použiteľné; dôležitejšie než výber je, aby sa u toho istého pacienta nemenila a aby sa hodnota zaznamenávala.
3. **Nezostať pri antihistaminikách.** Ich rozšírené podávanie je zvyk, nie dôkaz; polovica liečených z nich nemá úžitok a u starších pacientov prináša útlm a riziko pádov.

4. **Prejsť odstrániteľné príčiny.** Xerózu, dávku dialýzy, fosfátovo-kalciovú rovnováhu a parathormón, anémiu, liekovú anamnézu a kožné ochorenie, ktoré s obličkami nesúvisí.
5. **Vedieť, že existujú cielené možnosti.** Súčasné európske prehľady k liečbe pruritu pri dialýze uvádzajú aj gabapentinoídy, fototerapiu a agonisty k-opioidných receptorov – tieto údaje však pochádzajú z inej literatúry než z opisovanej štúdie.
6. **Zmeniť prostredie rozhovoru.** Ak pacient váha ozvať sa, keď je personál zaneprázdnený, pomôže zaradiť otázku na svrbenie do pevnej štruktúry kontroly, nie ju ponechať na jeho iniciatívu.

Poznámka k spoľahlivosti zdroja

Práca je voľne dostupná a jej kvalitatívna časť je poctivo urobená, obsahuje však aj nezrovnalosti, ktoré redakčná kontrola nezachytila: vekové kategórie sú v dvoch tabuľkách obsadené navzájom opačne a časť podielov v tabuľke liečby má odlišné menovatele bez upozornenia. Z tohto dôvodu tento text nepreberá zo štúdie žiadne vekové údaje. Sekundárna spravodajská správa o štúdiu navyše autorkám pripisuje tvrdenie o prenositeľnosti na severoamerickú populáciu, ktoré sa v pôvodnom článku nenachádza.

Záver

Zo štúdie si netreba odniesť číslo, ale mechanizmus. Prevalencia symptómu závisí od nástroja a prahu, takže rozdiel medzi 16 a 40 % je do veľkej miery sporom o meraní. Pripísať ho *výlučne* nástroju by však bolo predčasné: nijaká z týchto prác neporovnávala škály head-to-head v tej istej kohorte, takže skutočné rozdiely medzi populáciami (skladba pacientov, ročné obdobie, dialyzačná prax, komorbidita) sa vylúčiť nedajú. Klinicky použiteľné zistenie je iné a nemenej dôležité: **pacienti o svrbení nehovoria, dostávajú liečbu, ktorá im v polovici prípadov nepomáha, a s oboma vecami vieme niečo urobiť hneď.**

Súvisiace články

- [Neuroimunitná architektúra uremického pruritu: model štyroch uzlov a jeho terapeutické dôsledky](#)
- [Kŕče kostrového svalstva pri dialýze: globálna prevalencia 55 % a čo s tým v praxi](#)
- [Stanovenie suchej váhy \(EDW\) pri hemodialýze: klinický odhad, BCM, BVM a POCUS](#)

Spracovaný zdroj: Turgay G, Özdemir Eler Ç. Chronic Kidney Disease-Associated Pruritus in Haemodialysis: A Mixed-Methods Study of Symptom Burden and Patient Experience. *Journal of Renal Care*. 2026;52(3):e70075. doi: 10.1111/jorc.70075. [Plný text](#). [PubMed](#).

Pôvodná publikácia škály 5-D: Elman S, Hynan LS, Gabriel V, Mayo MJ. The 5-D itch scale: a new measure of pruritus. *British Journal of Dermatology*. 2010;162(3):587–593. doi: 10.1111/j.1365-2133.2009.09586.x. [PubMed](#).

Zdroj použitých hraníc závažnosti: Lai JW, Chen HC, Chou CY, Yen HR, Li TC, Sun MF, Chang HH, Huang CC, Tsai FJ, Tschen J, Chang CT. Transformation of 5-D itch scale and numerical rating scale in chronic hemodialysis patients. *BMC Nephrology*. 2017;18(1):56. doi: 10.1186/s12882-017-0475-z. [PubMed](#).

Porovnávacía prevalencia: Lanot A, Bataille S, Rostoker G, Bataille P, Chauveau P, Touzot M, Misery L. Moderate-to-severe pruritus in untreated or non-responsive hemodialysis patients: results of the French prospective multicenter observational study Pruripreva. *Clinical Kidney Journal*. 2023;16(7):1102–1112. doi: 10.1093/ckj/sfad032. [PubMed](#).

Súčasný prehľad diagnostiky a liečby: Latus J, Lanot A, Ständer S, Sanchez-Alvarez E, Aucella F, Yosipovitch G. CKD-associated pruritus in haemodialysis: a road map for diagnosis and treatment. *Clinical Kidney Journal*. 2025;18(5):sfaf096. doi: 10.1093/ckj/sfaf096. [Plný text](#).

Poznámka k dôkazovému základu: Bibliografické údaje, autorstvo aj všetky číselné výsledky boli overené 23. augusta 2026 z otvoreného plného textu spracovanej práce, z PubMedu a z Crossrefu. Podiely vnímaného účinku liečby sú vlastným prepočtom na počet skutočných užívateľov liekov; pôvodná práca ich vzťahuje na celý súbor užívateľov. Vekové údaje sa z dôvodu vnútornej nezrovnalosti v pôvodných tabuľkách neuvádzajú.

Zdroj: <https://nefro.polascin.net/article.php?slug=svrbenie-pruritus-na-dialyze-preco-sa-udavana-prevalencia-lisi-dvojnásobne-a-co-pacient-sam-nepovie> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.